

a4_discharge_parser 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:10:31

测试时间：2026-05-08 20:10:31

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=568 markers=4

禁用工具 success=True chars=958 markers=25

工具说明：tool_近况摘要:tool_近况摘要：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_基础信息:tool_基础信息：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

《出院摘要结构化包》

患者姓名：陈萍忠

性别：女

一、住院期间BPSD类型

拒绝康复、活动回避

二、住院期间BPSD频次

3次/周

三、有效干预记录

音乐引导+陪伴沟通后情绪于10分钟内缓解，共2次

四、无效干预记录

直接口头督促康复失败，1次

五、药物调整项

降压药由缬沙坦80mg调整为缬沙坦160mg，每日1次

六、出院NPI评分

16分

七、出院ADL评分

68分

八、触发因素清单

- 陌生环境
- 晨间集体训练
- 睡眠不足次日

九、高风险提示

- 跌倒风险：中高
- 认知波动风险：中等

十、出院医嘱

1. 规律服用降压、调脂药物；
2. 每日监测血压1次；
3. 避免剧烈活动，做好跌倒防护；
4. 定期复查头颅CT及心电图；
5. 照护中重点关注认知相关行为，实施非药物干预；
6. 关注家属照护焦虑，必要时提供心理支持。

十一、返院承接建议

- 出院首周实施一对一活动引导；
- 加强晨间防跌倒巡视。

十二、家属配合要求

- 每日晚间反馈患者行为变化；
- 督导患者规律服药。

十三、下次复诊建议时间

出院后14天内，复诊神经内科与心内科。

【禁用工具输出摘录】

出院摘要结构化包

患者基本信息

姓名：陈萍忠
性别：女
籍贯：上海
学历：小学
婚姻状况：丧偶
子女情况：育有1名子女
宗教信仰：无
日常喜好：跳舞

基础疾病与既往史

- 阿尔茨海默病性痴呆（2019年12月 – 2020年4月曾入住上海精神卫生中心）

- 心脏起搏器植入术后
- 胆囊切除术后状态
- 2024年7月体检异常：血压偏高、血脂异常、心电图T波改变

本次住院概况

入院原因：头部外伤急诊入院
影像学检查：CT提示右额部皮下血肿、老年性脑改变
住院期间生命体征：平稳，心率60次/分，睡眠规律
治疗措施：止血、营养神经治疗
出院状态：症状好转，准予出院

结构化临床信息

1. **住院期间BPSD类型**：拒绝康复、活动回避
2. **住院期间BPSD频次**：3次/周
3. **有效干预记录**：音乐引导联合陪伴沟通后，情绪在10分钟内缓解，共2次
4. **无效干预记录**：直接口头督促康复训练失败，1次
5. **药物调整项**：降压药物由缬沙坦80mg qd 调整为 缬沙坦160mg qd
6. **出院NPI评分**：16分
7. **出院ADL评分**：68分
8. **触发因素清单**：陌生环境、晨间集体训练、睡眠不足次日
9. **高风险提示**：
 - 跌倒风险：中高
 - 认知波动风险：中等

出院医嘱

- 规律服用降压、调脂药物
- 每日监测血压1次
- 避免剧烈活动
- 做好跌倒防护措施
- 定期复查头颅CT及心电图
- 照护中重点关注认知相关行为症状（BPSD）
- 优先采用非药物干预策略
- 关注家属照护过程中的焦虑情绪，必要时提供心理支持

返院承接建议

- 出院后首周实施一对一活动引导
- 每日晨间安排防跌倒专项巡视

家属配合要求

- 每日晚间向照护团队反馈患者当日行为变化
- 督导患者按时、按量规律服药

下次复诊建议时间

- 出院后14天内，同步复诊神经内科与心内科